BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Số: /KH-PĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Bảo đảm khám, điều trị kịp thời năm 2026–2027 – phần điều dưỡng
(Tiêu chí A4.1, mục tiêu mức 4)

I. THỰC TRẠNG

- Số liệu thời gian chờ hiện có: chờ nhận thuốc 18 phút (năm 2024). Chưa đo thời gian chờ đăng ký, chờ khám, chờ cận lâm sàng, chờ nhập viện.
- Chưa có quy trình phân loại ưu tiên bằng văn bản tại Khoa Khám bệnh; chưa áp dụng bảng điểm cảnh báo sớm ở khoa nội trú.
- Năm 2026 có 08 sự cố liên quan tính kịp thời, trong đó 03 sự cố nghiêm trọng (đã ẩn danh):

Ngày	Khoa	Sự cố	Mức độ
21/04/2026	Nội tổng hợp	Chậm trình bác sĩ đọc điện tim, phát hiện nhồi máu cơ tim muộn	Nghiêm trọng
21/04/2026	Nội tổng hợp	Cho y lệnh đo ECG nhưng không kiểm tra kết quả	Trung bình
28/03/2026	Khám bệnh	Sàng lọc mức độ nặng chưa đầy đủ ở người bệnh ngoại kiều, giao tiếp khó khăn	Nghiêm trọng
29/05/2026	Khám bệnh	Phân loại bệnh chưa chính xác tại phòng khám	Nhẹ
30/06/2026	Ngoại tổng quát	Người bệnh đau quặn thận được mời khám và nhập khoa Nội thay vì Ngoại	Trung bình
22/07/2026	Nội tổng hợp	Chưa trình bệnh cho bác sĩ trực gây thiếu sót chẩn đoán	Nhẹ
23/07/2026	Nội tổng hợp	Chỉ định cận lâm sàng chưa phù hợp trên người bệnh suy tim, chậm xử trí khi SpO2 giảm	Nghiêm trọng
19/08/2026	Nội tổng hợp	Thiếu giường bệnh khi tiếp nhận người bệnh mới trong đêm	Nhẹ

Điểm chung: chậm nhận diện người bệnh nặng, chậm trình bác sĩ, kết quả điện tim không được đọc kịp thời. Đây là căn cứ xây dựng SOP-A4.1-01 và SOP-A4.1-02.

II. MỤC TIÊU

1. Ban hành QĐ-A4.1, SOP-A4.1-01, SOP-A4.1-02 sau khi Hội đồng chuyên môn duyệt ngưỡng (10–11/2026).
2. Đo thời gian chờ 30 người bệnh/tháng từ 11/2026; có trung vị từng khoảng chờ theo tháng.
3. Áp dụng NEWS2 tại 100% khoa nội trú người lớn trong quý I/2027.

4. Không có sự cố chậm nhận diện, chậm báo bác sĩ gây hại.

III. BỘ CHỈ SỐ

Mã	Chỉ số	Công thức	Mục tiêu	Tần suất	Nguồn
KPI-A4.1-01	Thời gian chờ khám (trung vị, phút)	Từ lúc đăng ký xong đến lúc được bác sĩ khám, đo 30 NB/tháng	Giảm liên tục	Tháng	BM-A4.1-01
KPI-A4.1-02	Thời gian chờ có kết quả cận lâm sàng thường quy (trung vị, phút)	Từ lúc có chỉ định đến lúc có kết quả	Giảm liên tục	Tháng	BM-A4.1-01
KPI-A4.1-03	Thời gian từ chỉ định nhập viện đến khi NB vào khoa (trung vị, phút)	Từ giờ ký chỉ định nhập viện đến giờ khoa nhận NB	≤ 60 phút (mốc nội bộ)	Tháng	BM-A4.1-01
KPI-A4.1-04	Tỷ lệ NB phân loại mức Đỏ được xử trí ngay	Số NB Đỏ được bác sĩ tiếp nhận ngay / số NB Đỏ × 100%	≥ 95%	Tháng	BM-A4.1-02
KPI-A4.1-05	Tỷ lệ NB đau ngực được ghi điện tim trong 10 phút	Số NB đau ngực có ECG ≤ 10 phút từ lúc đến / số NB đau ngực × 100%	≥ 90%	Tháng	BM-A4.1-02
KPI-A4.1-06	Tỷ lệ NB nội trú có NEWS2 ≥ 5 được báo bác sĩ đúng thời gian	Số lượt báo đúng thời gian / số lượt NEWS2 ≥ 5 × 100%	100%	Tháng	BM-A4.1-04
KPI-A4.1-07	Tỷ lệ NB hài lòng về thời gian chờ	Theo khảo sát ngoại trú của Phòng QLCL	≥ 90%	Quý	Khảo sát QLCL

IV. HOẠT ĐỘNG

Thời gian	Hoạt động	Phụ trách
10/2026	Trình Hội đồng chuyên môn duyệt ngưỡng phân loại, NEWS2; trình ký	PĐD, KHTH
11/2026	Tập huấn phân loại cho điều dưỡng Khoa Khám bệnh; bắt đầu BM-A4.1-01, -02	PĐD, Khoa Khám bệnh
11–12/2026	Tập huấn NEWS2, báo cáo ISBAR; thí điểm tại Khoa Nội tổng hợp (nơi có 3/8 sự cố)	PĐD
12/2026	Phân tích nguyên nhân gốc nhóm sự cố chậm xử trí (SOP-A4.2-02)	PĐD, KHTH, QLCL
Quý I/2027	Mở rộng NEWS2 toàn viện; tích hợp tính điểm trên HIS nếu được	PĐD, CNTT
Quý II/2027	Đánh giá 6 tháng; đề xuất gọi số điện tử, bảng theo dõi thời gian chờ (mức 5)	BGĐ, QLCL, CNTT

Ghi chú: *Tiêu chí A4.1 do Phòng KHTH, Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu, Phòng QLCL thực hiện chính; Phòng Điều dưỡng chủ trì phần phân loại, báo động sớm, đo thời gian chờ.*

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng KHTH, Phòng QLCL;
- Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu, các khoa nội

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

trú;
- Lưu: PĐD.